# LAPORAN KEGIATAN

# FOCUS GROUP DISCUSSION DAN WORKSHOP CO-DESIGN INTERVENSI INTERCEPT

*Identifikasi dan Pemutusan Titik Transmisi Bakteri Gram-Negatif Resisten Karbapenem melalui Intervensi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi*

**8–10 Oktober 2026**

**FAKULTAS KEDOKTERAN**
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**
**2026**

**HALAMAN PENGESAHAN**
**LAPORAN KEGIATAN**

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Judul Kegiatan | : | Focus Group Discussion dan Workshop Co-Design Intervensi INTERCEPT: Identifikasi dan Pemutusan Titik Transmisi Bakteri Gram-Negatif Resisten Karbapenem melalui Intervensi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi |
| 2 | Ketua Pelaksana | : | |
| | a. Nama | : | Dr. dr. Nur Farhanah, Sp.PD., Subsp. K-PTI |
| | b. NIP/ Pangkat/ Gol | : | [NIP / pangkat / golongan] |
| | c. Fakultas/ Jurusan | : | Kedokteran |
| | d. Telepon | : | [nomor telepon] |
| | e. Faks | : | - |
| | f. Email | : | [alamat email] |
| 3 | Jangka Waktu Pelaksanaan | : | 8 – 10 Oktober 2026 |

Semarang, 20 Oktober 2026
Ketua Pelaksana

Dr. dr. Nur Farhanah, Sp.PD., Subsp. K-PTI
NIP [NIP]

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Infeksi oleh bakteri Gram-negatif multiresisten saat ini menjadi salah satu problem kesehatan yang mendesak, baik di tingkat rumah sakit, daerah, negara, maupun dunia, karena menyebabkan peningkatan gagal terapi antimikroba, masa rawat yang lebih panjang, komplikasi, dan kematian. Transmisi bakteri Gram-negatif resisten karbapenem (*carbapenem-resistant Gram-negative bacteria*/CR-GNB) di rumah sakit dapat terjadi melalui rangkaian kontak antara pasien, tangan atau sarung tangan petugas, alat medis, perangkat invasif, obat atau cairan yang disiapkan dan diberikan, serta lingkungan pelayanan. Karena itu, pencegahan transmisi tidak cukup hanya dengan kebijakan umum Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). Pencegahan memerlukan identifikasi titik-titik spesifik dalam proses pelayanan tempat mikroorganisme dapat berpindah, dan intervensi yang mampu memutus perpindahan tersebut.

INTERCEPT (*INTerrupting prolifERation of Carbapenem resistance in Indonesia: clinical and genomic Evaluation of Pathways of Transmission*) Study merupakan kolaborasi Universitas Diponegoro dan Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM). Fase pertama penelitian mengintegrasikan data klinis, mikrobiologi, genomik, lingkungan, dan kualitatif untuk memahami jalur transmisi CR-GNB di RSUP Dr. Kariadi Semarang, RS K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang, dan RSUD Dr. M. Ashari Pemalang.

Temuan fase pertama menunjukkan pentingnya tenaga kesehatan dan lingkungan dalam jalur transmisi. Observasi praktik pelayanan juga menunjukkan adanya peluang transmisi pada tindakan rutin, misalnya penggunaan sarung tangan tanpa hand hygiene yang memadai, perpindahan dari tindakan atau lokasi kotor ke tindakan atau lokasi yang lebih bersih, manipulasi perangkat invasif, penggunaan alat bersama, serta kontak berulang dengan permukaan lingkungan.

Berdasarkan temuan tersebut, fase intervensi INTERCEPT difokuskan pada PPI, khususnya identifikasi *transmission opportunities* dalam prosedur medis, keperawatan, kefarmasian dan penyiapan obat, penggunaan dan pemeliharaan alat, serta pembersihan lingkungan. Focus Group Discussion (FGD) dan workshop co-design ini diselenggarakan agar setiap rumah sakit dapat memilih titik transmisi yang paling relevan, menentukan *feasible transmission break*, dan menyusun rencana implementasi yang sesuai dengan konteks local setiap rumah sakit.

## B. TUJUAN

**Tujuan umum** kegiatan ini adalah menyusun secara kolaboratif intervensi PPI yang terarah untuk memutus titik-titik transmisi CR-GNB yang sering terjadi dalam proses pelayanan rumah sakit.

**Tujuan khusus:**

1. Memaparkan jalur transmisi dan *transmission opportunities* yang teridentifikasi dari fase pertama INTERCEPT.
2. Mengidentifikasi prosedur/tindakan yang paling sering membuka peluang perpindahan CR-GNB di masing-masing rumah sakit.
3. Mengidentifikasi titik kritis dalam urutan tindakan, termasuk perpindahan patient–hands/gloves–environment–device dan *dirty-to-clean/aseK-PTIc task transitions*.
4. Menilai *feasibility* dan *acceptability* berbagai *transmission breaks* pada titik-titik prioritas.
5. Menyusun paket intervensi PPI yang spesifik terhadap prosedur dan konteks masing-masing rumah sakit.
6. Menetapkan PIC, kebutuhan sarana, pelatihan, audit, dan indikator implementasi pelaksanaan intervensi
7. Memperoleh *management review* dan *endorsement* terhadap *Site-Specific INTERCEPT Transmission Prevention Plan*.

# BAB II
# LAPORAN KEGIATAN

## A. TANGGAL DAN LOKASI

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal | : Kamis – Sabtu, 8 – 10 Oktober 2026 |
| Waktu | : Sesuai rundown (Hari 1 dan 2: 08.00 – 17.00 WIB; Hari 3: 08.00 – 13.30 WIB) |
| Tempat | : Hotel Aruss, Jl. dr. Wahidin 116, Semarang |

## B. PESERTA KEGIATAN

1. Pimpinan rumah sakit/direksi.
2. Tim PPI, IPCN, dan perwakilan unit pelayanan prioritas.
3. Ketua Komite Medik / Ketua Tim PPRA.
4. Keperawatan/kepala ruang, terutama ICU/NICU dan unit prioritas.
5. Instalasi Farmasi/farmasi klinik, terutama terkait penyiapan obat, antiseK-PTIk, dan disinfektan.
6. Cleaning service/pemeliharaan kebersihan lingkungan dan sarana.
7. Pemangku kepentingan pemerintah terkait.
8. Tim INTERCEPT UNDIP dan LSTM.

Peserta berasal dari tiga rumah sakit mitra INTERCEPT: RSUP Dr. Kariadi Semarang, RS K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang, dan RSUD Dr. M. Ashari Pemalang. Jumlah peserta yang hadir: x orang.

## C. RUNDOWN KEGIATAN

| Waktu (WIB) | Agenda | PIC/Narasumber |
|---|---|---|
| **Hari 1 – Kamis, 8 Oktober 2026 \| understanding where transmission happens** | | |
| 08.00–09.00 | Registrasi | Ajeng, Atik |
| 09.00–09.10 | Pembukaan | MC |
| 09.10–09.15 | Sambutan INTERCEPT Indonesia | Helmia Farida |
| 09.15–09.20 | Sambutan INTERCEPT LSTM | Joseph Lewis |
| 09.20–09.45 | Sambutan dan pembukaan resmi kegiatan | Rektor Universitas Diponegoro |
| 09.45–10.00 | Problem resistensi antimikroba di Semarang dan Jawa Tengah: hasil penelitian FK UNDIP 2024 | Helmia Farida / Tim INTERCEPT |

| Waktu (WIB) | Agenda | PIC/Narasumber |
|---|---|---|
| 10.00–10.25 | Key Findings from INTERCEPT Phase 1: CR-GNB Transmission Pathways, Environmental/Staff Reservoirs and Intervention Targets | Joseph Lewis / Tim INTERCEPT |
| 10.25–10.45 | Coffee break dan diskusi | Moderator |
| 10.45–11.00 | Masalah, Kebijakan dan Strategi Pengendalian AMR melalui Pencegahan Transmisi dan Penatagunaan Antimikroba di RSUD dr. Ashari | Direktur RSUD Dr. M. Ashari |
| 11.00–11.15 | Masalah, Kebijakan dan Strategi Pengendalian AMR melalui Pencegahan Transmisi dan Penatagunaan Antimikroba di RS K.R.M.T. Wongsonegoro | Direktur RS K.R.M.T. Wongsonegoro |
| 11.15–11.30 | Masalah, Kebijakan dan Strategi Pengendalian AMR melalui Pencegahan Transmisi dan Penatagunaan Antimikroba di RS dr. Kariadi | Direktur RSUP Dr. Kariadi |
| 11.30–11.50 | Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengendalian AMR di Propinsi Jawa Tengah | Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah |
| 11.50–12.10 | Kebijakan nasional pengendalian AMR di rumah sakit rujukan dengan penekanan pada PPI dan pemutusan transmisi | Kementerian Kesehatan RI |
| 12.10–12.30 | Diskusi | Moderator: Nur Farhanah |
| 12.30–13.30 | ISHOMA | |
| 13.30–14.45 | Pengantar: 246 potential transmission point/events<br>**FGD 1** – Where Does Transmission Happen? Identifikasi transmission opportunities yang sering dijumpai: patient–hands/gloves–environment–equipment–device | Fasilitator: Rebriarina Hapsari<br>FGD; kelompok per rumah sakit |
| 14.45–15.00 | Coffee break | |
| 15.00–16.30 | Pengantar: Urutan Tindakan Bersih – Kotor<br>**FGD 2** – Walking Through High-Risk Care Pathways: pemetaan urutan tindakan dan titik dirty-to-clean/aseK-PTIc, environment-to-patient, glove-mediated, shared-equipment dan device-related transmission | Fasilitator: Joseph Lewis<br>FGD; kelompok per rumah sakit |
| 16.30–17.00 | Pleno: prioritas transmission points dari masing-masing rumah sakit dan briefing Hari 2 | Tim INTERCEPT + perwakilan RS |
| **Hari 2 – Jumat, 9 Oktober 2026 \| CO-DESIGNING TRANSMISSION BREAKS** | | |

| Waktu (WIB) | Agenda | PIC/Narasumber |
|---|---|---|
| 08.00–08.20 | Recap: What We Heard Yesterday – prioritas transmission points dari tiga rumah sakit | Tim INTERCEPT |
| 08.20–08.40 | From Transmission Point to Transmission Break: Cara Menerjemahkan Temuan INTERCEPT dan FGD Menjadi Intervensi PPI yang spesifik | Tim INTERCEPT |
| 08.40–09.10 | **Transmission Break 1** – Hand Hygiene, Glove Use and Task Transition: termasuk sarung tangan bukan pengganti hand hygiene; glove change + HH pada dirty-to-clean/aseK-PTIc transition | Tim INTERCEPT / PPI |
| 09.10–09.40 | **Transmission Break 2** – Vascular Access and Invasive Devices: skin antisepsis, critical-part protection, hub/port disinfection, line manipulation dan device maintenance | Tim INTERCEPT / PPI |
| 09.40–10.10 | **Transmission Break 3** – Airway, Respiratory, Elimination, Wound and Enteral Care: pemutusan transmisi selama prosedur berisiko sekret/feses/urine dan transisi ke clean/aseK-PTIc care | Tim INTERCEPT / PPI |
| 10.10–10.25 | Coffee break | |
| 10.25–10.55 | **Transmission Break 4** – Safe Medication Preparation and Administration: clean preparation area, aseK-PTIc handling, vial septum dan IV hub/port disinfection | Tim INTERCEPT / Farmasi / PPI |
| 10.55–11.25 | **Transmission Break 5** – Shared Medical Equipment and High-Touch Patient Environment: siapa membersihkan, kapan, dengan apa, dan bagaimana memastikan alat siap digunakan pasien berikutnya | Tim INTERCEPT / PPI |
| 11.25–12.45 | ISHOMA dan Shalat Jumat | |
| 12.45–13.15 | **Transmission Break 6** – Environmental Cleaning & Disinfection: clean-to-dirty workflow, cloth/mop, disinfectant concentration/contact time, wet areas dan terminal cleaning | Tim INTERCEPT / PPI / Cleaning Service |
| 13.15–13.40 | **Transmission Break 7** – Medical Procedures, Patient/Equipment Movement and Inter-unit Transmission: protection of critical sites/parts, transport equipment dan komunikasi saat transfer | Tim INTERCEPT / PPI |

| Waktu (WIB) | Agenda | PIC/Narasumber |
|---|---|---|
| 13.40–14.40 | **FGD 3** – Feasibility and Acceptability of Candidate Transmission Breaks: Accept as is / Modify / Not feasible; alasan dan adaptasi lokal | FGD terpisah per rumah sakit |
| 14.40–14.55 | Coffee break | |
| 14.55–16.15 | **Co-design Workshop** – Designing Our Site-Specific Transmission-Breaking Intervention Package: memilih transmission points prioritas dan menyusun bundle/checklist/SOP mikro | Working group per rumah sakit |
| 16.15–16.45 | **Cross-hospital feedback**: perbandingan prioritas, adaptasi dan kebutuhan dukungan antar-rumah sakit | Pleno |
| 16.45–17.00 | Ringkasan Hari 2 dan briefing finalisasi Hari 3 | Tim INTERCEPT |
| **Hari 3 – Sabtu, 10 Oktober 2026 \| FROM CO-DESIGN TO IMPLEMENTATION** | | |
| 08.00–08.15 | Recap Hari 2 dan tujuan Hari 3 | Tim INTERCEPT |
| 08.15–09.00 | **FGD 4** – Final Feasibility, Acceptability and Adaptation Review terhadap paket transmission breaks masing-masing rumah sakit | FGD terpisah per rumah sakit |
| 09.00–09.45 | **Implementation Planning Workshop:** Who Does What, When and With What Resources? PIC, supplies, training, audit, feedback, indikator dan timeline | Working group per rumah sakit |
| 09.45–10.00 | Coffee break | |
| 10.00–10.30 | Finalisasi Site-Specific INTERCEPT Transmission Prevention and Implementation Plan | Working group per rumah sakit |
| 10.30–10.40 | Leadership Session: ringkasan proses co-design dan pengantar rencana final | Tim INTERCEPT |
| 10.40–11.10 | RSUD Dr. M. Ashari: presentasi transmission points prioritas, transmission breaks, rencana implementasi dan management response | Tim RS + Direktur sebagai Executive Reviewer |
| 11.10–11.40 | RS K.R.M.T. Wongsonegoro: presentasi transmission points prioritas, transmission breaks, rencana implementasi dan management response | Tim RS + Direktur sebagai Executive Reviewer |
| 11.40–12.10 | RSUP Dr. Kariadi: presentasi transmission points prioritas, transmission breaks, rencana implementasi dan management response | Tim RS + Direktur sebagai Executive Reviewer |

| Waktu (WIB) | Agenda | PIC/Narasumber |
|---|---|---|
| 12.10–12.25 | Joint Management Endorsement of INTERCEPT Site-Specific Transmission Prevention Plans | Direktur/pejabat senior berwenang + INTERCEPT |
| 12.25–12.30 | Penutupan dan tindak lanjut | Tim INTERCEPT |
| 12.30–13.30 | Makan siang dan kepulangan | |

## D. DAFTAR SUSUNAN PANITIA

| Nama | Keterangan |
|---|---|
| 1. Rektor Universitas Diponegoro | Pelindung |
| 2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro | Penanggung Jawab |
| 3. dr. Joseph M. Lewis, Ph.D | Penasihat Ilmiah (Scientific Advisor) – Principal Investigator INTERCEPT, LSTM |
| 4. dr. Helmia Farida, M.Kes., Ph.D., Sp.A (K) | Pengarah Ilmiah (Scientific Lead) – Principal Investigator INTERCEPT, Universitas Diponegoro |
| 5. Dr. dr. Nur Farhanah, Sp.PD., Subsp. K-PTI | Ketua Pelaksana |
| 6. Rahajeng Putu, S.P | Sekretaris |
| 7. Atik Alami, S.Pd | Bendahara |
| 8. dr. Rebriarina Hapsari, Sp.MK<br>9. dr. Endang Sri Lestari, Ph.D | Seksi Acara |
| 10. dr. Shada Amani NS | Seksi Logistik dan Akomodasi |
| 11. dr. Arsyadila Nur Sabila<br>12. dr. Aufa Al Masa | Seksi Data dan Sidang |
| 13. Rahajeng Putu, S.P<br>14. Atik Alami, S.Pd | Seksi Konsumsi |

# BAB III
# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

1. Focus Group Discussion dan Workshop Co-Design Intervensi INTERCEPT terlaksana pada 8 – 10 Oktober 2026 di Hotel Aruss, Semarang, dengan tiga rangkaian utama: pemetaan titik transmisi (Hari 1), perancangan *transmission breaks* (Hari 2), dan penyusunan rencana implementasi serta *management endorsement* (Hari 3).
2. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan RSUP Dr. Kariadi, RS K.R.M.T. Wongsonegoro, dan RSUD Dr. M. Ashari, bersama tim INTERCEPT UNDIP dan LSTM, serta pemangku kepentingan pemerintah daerah dan nasional.
3. Setiap rumah sakit menyusun *Site-Specific INTERCEPT Transmission Prevention and Implementation Plan* yang memuat titik transmisi prioritas, *transmission breaks*, PIC, kebutuhan sumber daya, pelatihan, indikator, dan jadwal pelaksanaan.

## B. UCAPAN TERIMA KASIH

Panitia menyampaikan apresiasi kepada Rektor dan pimpinan Universitas Diponegoro, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Liverpool School of Tropical Medicine, para direktur dan tim dari RSUP Dr. Kariadi, RS K.R.M.T. Wongsonegoro, dan RSUD Dr. M. Ashari, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Kesehatan RI, para narasumber, fasilitator, serta seluruh peserta atas dukungan sehingga pelaksanaan FGD dan Workshop Co-Design Intervensi INTERCEPT berjalan dengan baik.

## C. PENUTUP

Rangkaian kegiatan ini diharapkan mendorong intervensi PPI yang spesifik, dapat diamati, dapat diaudit, dan langsung terkait dengan tujuan utama INTERCEPT, yaitu memutus rantai transmisi bakteri Gram-negatif resisten karbapenem di rumah sakit. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta dasar perbaikan bagi penyelenggaraan kegiatan serupa di masa mendatang.

Semarang, [tanggal] Oktober 2026
Ketua Pelaksana

Dr. dr. Nur Farhanah, Sp.PD., Subsp. K-PTI
NIP [NIP]

# LAMPIRAN

## DOKUMENTASI KEGIATAN\

### Day 1







FOCUS GROUP DISCUSSION
DAN WORKSHOP CO-DESIGN INTERVENTION
INTERCEPT

**Day 2**





**Day 3**


FOCUS GROUP DISCUSSION
DAN WORKSHOP CO-DESIGN INTERVENTION


FOCUS GROUP DISCUSSION
DAN WORKSHOP CO-DESIGN INTERVENTION